

# Übungsprogramm – Ellbogen

---

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

## Akute Schmerzbehandlung

---

### – Kühlung und Entlastung (Tennis- / Golferellbogen)

**Ausgangsposition:** Sitzen, Arm auf dem Oberschenkel oder auf einem Kissen abgelegt, Handgelenk neutral.

**Bewegung:** Eispackung (in Tuch) auf den schmerzenden Bereich (Außenseite: Tennisel-bogen / Innenseite: Golferellbogen) für 10–15 Minuten.

**Wofür:** Reduziert lokale Entzündungsreaktion an den Sehnenansätzen der Unterarmmuskulatur.

*Tipp: Direkt nach Belastung kühlen – 2–3 × täglich in der Akutphase.*

### – Unterarm-Faszien-Massage (Selbstmassage)

**Ausgangsposition:** Sitzen, betroffener Arm auf dem Oberschenkel, entspannt.

**Bewegung:** Mit dem Daumen der anderen Hand langsam entlang der Unterarmmuskulatur drücken und reiben – vom Handgelenk Richtung Ellbogen. An druckempfindlichen Stellen kurz verweilen.

**Wofür:** Löst Verspannungen und Verklebungen in der Unterarmmuskulatur – reduziert Zug auf den Sehnenansatz.

*Tipp: Kein aggressives Drücken – mittelstarker, gleichmäßiger Druck über 2–3 Minuten.*

---

2–3 × täglich in der Akutphase.

## Mobilisationsübungen

---

### – Pro-/Supination (Handfläche drehen)

**Ausgangsposition:** Sitzen, Ellbogen 90° gebeugt, eng am Körper, Unterarm horizontal.

**Bewegung:** Die Handfläche langsam nach oben drehen (Supination) und langsam nach unten drehen (Pronation). Gleichmäßig und kontrolliert, den vollen Bewegungsraum ausschöpfen.

**Wofür:** Mobilisiert das proximale und distale Radioulnargelenk – essenzielle Alltagsbewegung (z. B. Schlüssel umdrehen, Schrauben).

*Tipp: Ellbogen bleibt am Körper – nur der Unterarm dreht sich.*

### – Ellbogen-Beugung und -Streckung (aktiv)

**Ausgangsposition:** Sitzen oder Stand, Arm locker neben dem Körper.

**Bewegung:** Den Ellbogen langsam in die volle Beugung (Faust Richtung Schulter) und dann in die volle Streckung führen. Gleichmäßig, ohne Schwung.

**Wofür:** Hält die volle Beweglichkeit des Ellbogengelenks aufrecht und verhindert Kapselverdickung.

*Tipp: Bei der Streckung nicht überstrecken – bis in die neutrale gerade Position reicht es.*

---

2 Sätze à 15 Wiederholungen pro Richtung.

## Stabilitätsübungen

---

### – Handgelenk-Isometrie (neutral)

**Ausgangsposition:** Sitzen, betroffener Arm auf dem Oberschenkel oder Tisch, Handgelenk neutral (gerade).

**Bewegung:** Mit der anderen Hand leichten Widerstand gegen das Handgelenk geben – Handgelenk drückt dagegen ohne Bewegung. 5 Sekunden halten. In alle Richtungen: oben, unten, seitlich.

**Wofür:** Aktiviert die Unterarmstabilisatoren ohne dynamische Belastung der gereizten Sehnenansätze.

*Tipp: Wirklich nur leichter Widerstand – nicht maximal pressen in der Akutphase.*

### – Grip-Übung (Tennisball oder Therapieknete)

**Ausgangsposition:** Sitzen, Unterarm auf dem Oberschenkel, Tennisball oder Knete in der Hand.

**Bewegung:** Ball / Knete langsam und kontrolliert zusammendrücken, 3–5 Sekunden halten, langsam lösen.

**Wofür:** Kräftigt die Flexoren des Unterarms isometrisch und verbessert die funktionelle Griffkraft.

*Tipp: Schmerzen beim Drücken? Widerstand reduzieren oder weichere Knete verwenden.*

---

3 Sätze à 10–15 Wiederholungen. Pause: 60 Sekunden.

## Kraftübungen

---

### – Bizepscurl mit Theraband (exzentrisch betont)

**Ausgangsposition:** Stand, Theraband unter dem Fuß, Handfläche nach vorne.

**Bewegung:** Den Arm nach oben beugen (1 Sek.), kurz halten, dann sehr langsam strecken (3–4 Sekunden). Die Streckphase (exzentrisch) ist entscheidend.

**Wofür:** Exzentrisches Training hat die stärkste Evidenz bei Tendinopathien – fördert die Sehnenreparatur.

*Tipp: Das Gewicht / der Widerstand muss moderat sein – Qualität der Exzentrik vor Intensität.*

### – Trizepsstreckung am Band

**Ausgangsposition:** Stand, Theraband über eine Tür oder Halterung, Ellbogen neben dem Kopf, Unterarm hängt nach hinten.

**Bewegung:** Den Unterarm gegen den Widerstand strecken, Ellbogen bleibt oben, kurz halten, kontrolliert zurück.

**Wofür:** Kräftigt den Trizeps – wichtig für alle drückenden Bewegungen und die Ellbogenstabilität.

*Tipp: Ellbogen bleibt während der gesamten Bewegung auf gleicher Höhe.*

### – Handgelenk-Extension gegen Widerstand (Tennisellbogen-spezifisch)

**Ausgangsposition:** Sitzen, Unterarm auf dem Tisch, Handrücken nach oben, leichte Hantel (0.5–1 kg).

**Bewegung:** Das Handgelenk langsam anheben (Extension), kurz halten, dann sehr langsam absenken (3–4 Sek. exzentrisch).

**Wofür:** Stärkt die Handgelenksexpressoren direkt am Ursprung – gezielte Therapieübung bei Tennisellbogen (Epicondylitis lateralis).

*Tipp: Sehr leichtes Gewicht beginnen – auch 0.5 kg ist korrekt. Die Absenkphase ist das Wichtigste.*

---

3 Sätze à 10–15 Wiederholungen. Pause: 90 Sekunden.

---

### Allgemeine Hinweise

- Übungen 3 × pro Woche ausführen – bei Sehnenreizungen nicht täglich.
- Während der Therapie bei Alltagsaktivitäten (Tippen, Schrauben) auf die Handgelenksposition achten.
- Tennisellbogen: Gegenstände mit der Handfläche nach oben greifen (Supination) ist entlastender.
- Vibrierende Werkzeuge und starkes Greifen in der Akutphase vermeiden.
- Heilung von Sehnenreizungen dauert Wochen – regelmäßiges Training ist wichtiger als intensive Einheiten.